EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 81905
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-04-04 10:31:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: PEDRO FLORENCIO QUEZADA GODOY			**RUN**	: 6.109.150-5
F.Nac	: 01-12-1948	**Edad**	: 75 AÑOS, 4 MESES	**Género**	: Masculino
Dirección	: V MACKENNA 892			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-03-25	**Fecha Egreso**	: 2024-04-04 10:31:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J96.9-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Shock cardiogénico recuperado
2. ICC descompensada en edema agudo de pulmón (resuelto)
3. Traqueítis por staphylococcus aureus MS (En resolución)
4. Cardiopatía dilatada FEVI 30%.
5. Portador de Resincro-DAI
6. Arritmia cardiaca tipo FA en NACO
7. ERC estadio IV (Creat basal 1.9 mg/dl)
8. EPOC no tabáquico
9. HTA
10. Delirium hiperactivo
11. Desnutrición moderada por criterios GLIm

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I50-INSUFICIENCIA CARDIACA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente Que Se Encontraba En Buenas Condiciones En Su Domicilio Y Que Súbitamente Inicia Cuadro De Dificultad Respiratoria. Familia Lo Trae En Vehiculo Particular, Entra Directo A Reanimación. Se Constata Gasping Con Sat: 66% Con Livideces Generalizadas En Cuerpo Y Extremidades. Con Monitor Fa, Hemodimia Limite Bajo. Se Procede A Iot Con Sir (Midazolam, Fentanilo, Succinilcolina). Primer Intento Se Logra Sat 85% Con Salida De Abundante Contenido Liquido Por Vía Aerea. Se Define Continuidad De Cuidados En Uci Con Vmi. Se Comunica A Familiares Condición De Gravedad Y Mal Pronóstico. A Incios De Marzo Tuvo Hematoma Sublingual Por Coagulopatia. Tiene Estudio Ecocardio Con Fevi:30%. Tac Tx Cardiomegalia Con Marcapasos Bicameral Sin Derrame Pericárdico. Campos Pulmonares Con Condensación Con Broncograma Aéreo En Ambos Lóbulos Inferiores, En El Segmento Posterior Del Lóbulo Superior Derecho, Foco De Relleno Alveolar En Língula Y Lóbulo Medio. No Hay Derrame Pleural.
Ecocardiograma 02/09/2023: Vi Dilatado Con Hipertrofia Excéntrica Y Fevi Severamente Reducida 30%. Hipokinesia Septal Medial, Akinesia Apical, Hipokinesia Lateral Medio, Hipokinesia Anterior Medial, Hipokinesia Inferior Medio-Apical. Crecimiento Biauricular Moderado. Insuficiencia Mitral Moderada Insuficiencia Tricúspidea Leve Esclerocalcificación Aórtica Sin Evidencia De Estenosis Ni Insuficiencia. Disfunción Diastólica Con Patrón Monofasico. Ventrículo Derecho Normocontractil, Electrodos De Mcpd Dai-Resincro Visible
Con Buena Evolución Extubado 26/03/2024, Condición Estable.
Hemodinamia Estable, Ya Con Cifras De Pa Aceptables, Sin Dva, Vec Conservado, Bien Perfundido.

Al Monitor En Ritmo De Fa, Con Mejor Control De Fc. Ventilando Espontaneo, Buena Mecánica Respiratoria, Sin Requerimientos De Oxigeno, Sin Signos De Congestión Pulmonar. Afebril, Parámetros Inflamatorios Bajos, Pcr: 56 (38), Leuco: 10.500, Recibe Amoxicilina/Ac Clavulánico Hoy En Su Día 7. Función Renal Estable, Creatinina Dentro De Su Basal, Diuresis Adecuada Con Bh Negativos, Sin Dhe. Buen Control Metabólico, Tolerando Regimen Oral Parcialmente (Rechaza Algunas Comidas). Deposiciones(+). Cursando Con Delirium Hiperactivo, Con Lenguaje Coherente, Ayer Se Inició Neurolépticos, Los Cuales Se Suspendieron Por Somnolencia, Se Deja Solo Haloperidol En Sos, Sin Focalidad Neurológica. En Rehabilitación Kinésica, Se Levanta Y Camina Asistido.
Al Examen Físico:
Pa: 99/54 Mmhg; Pam: 62 Mmhg; Fc: 90 X´; Temp 36.1°; Sato2: 94%; Fio2: 21%
Bien Perfundido, Llene Capilar <3 Seg. Buena Coloración Cutaneomucosa.
Cuello: Yugulares No Ingurgitadas, Sin Bocio Ni Adenomegalias.
Tórax Simétrico, Normoexpansible, Sin Uma.
Mp Disminuido En Bases, Sin Agregados.
Rscs Arrítmicos, Con Shs Mitral Ii/Iv.
Abdomen Rshas +, No Impresionan Visceromegalias Y Sin Signos De Irritación Peritoneal.
Extremidades: Sin Edema, Dilataciones Venosas, Sin Signos De Tvp, Pulsos Presentes.
Neurológico: Consciente, Desorientado En Tiempo Y Espacio, Lenguaje Incoherente, Sin Focalidad Neurológica. En condiciones de alta médica.

PLAN DE MANEJO:

Hospitalizar en Hodom
Restricción hídrica 800 cc dia vo
Kiene motora y respiratoria
Control poli de cardiología,

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo Semisentado
2. Régimen Blando Hiposódico Restricción Hídrica 800 cc dia
3. Restricción Hídrica 1000cc 24 Horas
4. Omeprazol 20 mg Dia Vo
5. Apixabam 2.5 Mg Cada 12 Horas
6. Bisoprolol 2.5 Mg Dia Vo
7. Espironolactona 25 Mg Dia Vo
8. Empaglifozina 10 Mg Dia Vo
9. Furosemida 40 Mg Media Dia Vo
10. Lactulosa 20 Cc Vo Dia
11. Brexotide 25/250 2 Puff Cada 12
12. Bromuro Ipratropio 4 Puff Cada 6
13. Hgt Precocidas Y Refuerzo Ic

EXÁMENES Y RESULTADOS

Lab 02/04/24: Glic: 79 Crea: 2.1 Ca+: 8.3 Na+: 138 K+: 4.4 Cl-: 108 HGB: 14.9 HCTO: 43 PLaq: 138.000 PCR: 56 NU: 48 Uremia: 102
TAC tórax 23/03/2024: TOT bien posicionado. Cardiomegalia con marcapasos bicameral sin derrame pericárdico. Campos pulmonares con condensación con broncograma aéreo en ambos lóbulos inferiores, en el segmento posterior del lóbulo superior derecho, foco de relleno alveolar en língula y lóbulo medio. No hay derrame pleural.
Ecocardiograma 02/09/2023: VI dilatado con hipertrofia excéntrica y FeVI severamente reducida 30%. hipokinesia septal medial, akinesia apical, hipokinesia lateral medio, hipokinesia anterior medial, hipokinesia inferior medio-apical. Crecimiento biauricular moderado. Insuficiencia mitral moderada insuficiencia tricúspidea leve esclerocalcificación aórtica sin evidencia de estenosis ni insuficiencia. Disfunción diastólica con patrón monofasico. Ventrículo derecho normocontractil, electrodos de MCPD DAI-resincro visible

JEFE SERVICIO

CARABALLO DE HURTADO
JENNIFER DEL CARMEN
MEDICO TRATANTE
26251544-3